

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Soins palliatifs de premiers recours

Repères devant inconfort aigu en fin de vie, en attendant ou dans le cadre de prescriptions anticipées.

Indications

- Douleur, dyspnée, anxiété, encombrement ou inconfort de fin de vie.
- Projet de soins palliatifs identifié.
- Besoin d'application de prescriptions anticipées ou appel médical.

Vérifications préalables

- Vérifier projet de soins, directives connues et prescriptions anticipées.
- Évaluer symptôme principal et intensité.
- Prévenir entourage selon organisation et souhaits connus.
- Assurer environnement calme et présence humaine.

Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas improviser sédation ou voie d'administration non prescrite.
- Ne pas méconnaître urgence potentiellement réversible discutée avec médecin.
- Ne pas laisser symptôme intense sans appel médical.
- Ne pas oublier traçabilité des volontés et décisions.

Conduite à tenir

- Appliquer prescriptions anticipées si elles existent et sont claires.
- Mesures non médicamenteuses : positionnement, soins de bouche, ambiance calme.
- Contacter rapidement le médecin pour adaptation symptomatique.
- Informer et accompagner équipe et proches.

Surveillance et traçabilité

- Tracer symptômes, mesures de confort, traitements administrés et efficacité.
- Noter décisions médicales et information donnée aux proches.
- Surveiller soulagement, vigilance et confort global.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si symptôme non soulagé, agitation majeure ou dyspnée importante.
- Appel urgent si cadre palliatif non clarifié et détresse vitale en cours.

Mention de sécurité

Le confort prime, mais toute mesure médicamenteuse doit s'inscrire dans un cadre prescrit, tracé et partagé.

Fait à :

Le : / /

Signature :